

Regularne *jedzenie 3+2*

Pojedyncza najsilniejsza interwencja CBT-E. Schemat: 3 posiłki + 2 przekąski, maks. 4h przerwy. Wilson 2002: mediuje 50–70% redukcji epizodów. Antidotum na restrykcję.

CZAS: 20 min · wdrożenie Sesja 2 · pierwsza interwencja behawioralna

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Wilson, Fairburn, Agras i in. (2002)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **schemat 3+2** i jego logikę (sekcja 1), zobacz **sześć zasad wdrożenia** (sekcja 2). W sekcji 3 — Twój plan tygodniowy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Regularne jedzenie to **pojedyncza najsilniejsza interwencja** w CBT-E. Schemat **3+2**: trzy posiłki + dwie przekąski, *pięć okazji jedzenia*, z **maksymalną przerwą cztery godziny** między nimi. Wilson, Fairburn, Agras i in. (2002, RCT): samo wprowadzenie regularnego jedzenia **mediuje** redukcję napadów w CBT-E. Typowy efekt: epizody spadają o **50-70%** w ciągu 4-6 tygodni *tylko* dzięki regularnemu jedzeniu. Mechanizm: przerwanie cyklu *restrykcja → głód → epizod*. Gdy ciało wie, że jedzenie *przyjdzie* za 3-4 godziny, nie wchodzi w tryb napadowy. To **nie** jest „diet plan” — to *antidotum* na restrykcję, która napędza bulimię.

01 = Schemat 3+2 — logika

Pięć okazji jedzenia w ciągu dnia:

 Śniadanie (ok. 7-9) →  Przekąska poranna (ok. 10-11) →  Obiad (ok. 13-14) → 
Przekąska popołudniowa (ok. 16-17) →  Kolacja (ok. 19-20)

Klucz: maksymalna przerwa 4 godziny. Każda przerwa > 4h zwiększa ryzyko epizodu.

Schemat *nie jest* sztywny co do godzin — możesz go dopasować do swojego rytmu dnia. Klucz: **regularność** (pięć okazji) i **maksymalna przerwa** (cztery godziny). To *nie jest* „plan dietetyczny” — nie określa *co* ani *ile* jeść, tylko *kiedy*.

02 ☉ Sześć zasad wdrożenia

1 · PIĘĆ OKAZJI CO DZIEŃ

Codziennie 5 okazji jedzenia. Nawet w weekendy, podróżach, „stresujących dniach”. Konsekwencja > perfekcja.

2 · MAKS. 4H PRZERWY

Liczy się czas między posiłkami, nie zegar. Każda przerwa > 4h zwiększa ryzyko epizodu. Zaplanuj z wyprzedzeniem.

3 · NIE POMIJAJ „NA POKUTĘ”

Jeśli był epizod — **NIE** pomijaj następnego posiłku. To pułapka cyklu. Wróć do schematu od najbliższej okazji.

4 · NIE KOMPENSUJ

Po epizodzie — bez wymiotów, ćwiczeń kompensacyjnych, środków przeczyszczających. Tolerancja dyskomfortu (sekcja „Przerwij cykl”).

5 · NIE LICZY SIĘ CO

Klucz w tej fazie: *żeby*, nie *co*. Najpierw regularność, później ewentualna praca nad zawartością. Wybór diety — opcjonalny.

6 · PRIORYTET #1

W CBT-E to *najważniejsza* interwencja pierwszych 4 tygodni. Bez tego inne techniki mają znacznie słabszy efekt.

03

✎ Mój plan na nadchodzący tydzień

Zaplanuj **godziny** pięciu okazji jedzenia. Klucz to *regularność*, nie zawartość. Plan dopasuj do swojego dnia (praca, szkoła, opieka), ale trzymaj maksymalną przerwę 4h.

MOJE GODZINY PIĘCIU OKAZJI

— śniadanie, przekąska, obiad, przekąska, kolacja

CO PRZYGOTUJĘ W WEEKEND

— co kupić, co zaplanować, żeby ułatwić sobie tydzień

04

💡 Przewidywane trudności i adresowanie

„NIE MAM GŁODU RANO”

Ciało po latach restrykcji ma „uszkodzone” sygnały głodu. Jedz **mimo** braku głodu — przez 2-3 tygodnie wraca naturalny rytm.

„BOJĘ SIĘ, ŻE PRZYTYJĘ”

Większość osób po regularnym jedzeniu *nie* przybiera. Niektóre tracą — bo redukują epizody. Cotygodniowe ważenie z terapeutą daje obiektywne dane.

„NIE MAM CZASU NA PRZEKĄSKI”

Przekąska to 5 minut. Owoc, jogurt, garść orzechów, kanapka. Zaplanuj z *wyprzedzeniem* (w torbie, w pracy, w samochodzie).

„PO EPIZODZIE CHCĘ GŁODOWAĆ”

To pułapka cyklu. Głodówka *napędza* kolejny epizod. Wróć do schematu od najbliższej okazji — to *najtrudniejsza* ale *najważniejsza* część.

Klucz: regularne jedzenie 3+2 to *nie* diet, *nie* zalecenie żywieniowe, *nie* kontrola masy — to **antidotum** na biologiczną i psychologiczną restrykcję, która napędza bulimię. Wilson i in. (2002, RCT): regularne jedzenie *mediuje* 50-70% redukcji epizodów w CBT-E. To znaczy: pacjenci, którzy **jedyne** co zmienili to regularność (pięć okazji, maks. 4h), uzyskali większość efektu terapeutycznego bez innych interwencji. Mechanizm: mózg po latach restrykcji jest „na alarmie” — każda dłuższa przerwa aktywuje sygnały głodu i ryzyko epizodu. Regularne jedzenie *uczy* mózg, że jedzenie *przyjdzie* — i alarm się wycisza. To wymaga 2-3 tygodni: pierwsze dni są trudne (brak głodu, lęk przed jedzeniem), ale każdy następny tydzień staje się łatwiejszy. Cierpliwość. Cotygodniowe ważenie z terapeutą daje obiektywne dane — większość pacjentów *nie* przybiera, a wielu traci masę przez redukcję epizodów.